

社会医学講義： 精神保健

西山毅 p-gen@umin.ac.jp

精神保健とは

精神医療

- 医療機関で行う
- 対象：精神疾患の患者
 - 診断や治療

精神保健

- 地域で行う
- 対象：精神疾患の患者も患者以外も全員
 - 予防
 - 精神疾患の患者が地域で暮らすサポート

精神保健
福祉法

精神疾患はどれくらい多いか

4人に1人が罹患

• 世界

- 有病率：12.6 % [1]
- 生涯有病率：22.9% [2]
- 疾病負荷：全疾病負荷の14.6% [1]
 - ✓ 疾病負荷 = 病気により生じた支障の大きさ
= 失われた寿命の
+ 失われた健康

1: Neoplasms
2: Cardiovascular diseases
3: Musculoskeletal disorders
4: Other non-communicable diseases
5: Mental disorders
6: Unintentional injuries
7: Neurological disorders
8: Digestive diseases
9: Respiratory infections and tuberculosis
10: Chronic respiratory diseases

• 日本

- 有病率：7.6 % [3]
- 生涯有病率：20.3% [3]
- 疾病負荷→疾患群で5位

[1] Lancet Psychiatry 2022;9:137-150

[2] Int J Epidemiol 2014;43:476-93

[3] Epidemiol Psychiatr Sci 2016;25:217-29

日本の精神医療の特徴

患者調査

合計 / 受療率(人口10万対)

2020



日付(年) ▼

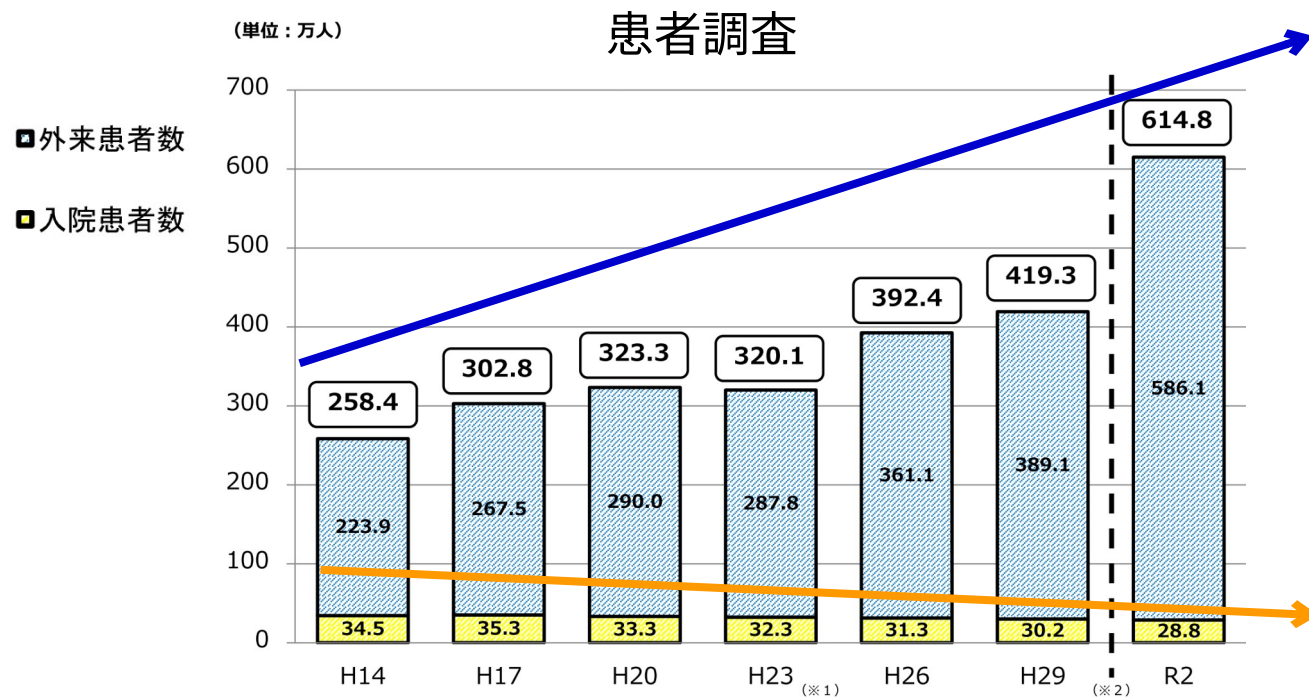
■ 2020

- 精神疾患が最も多く医療（外来＋入院）を受けている
 - 入院も最多←これが効いている！
 - 外来は他より少ない（10位以下）

入院の多さが際立

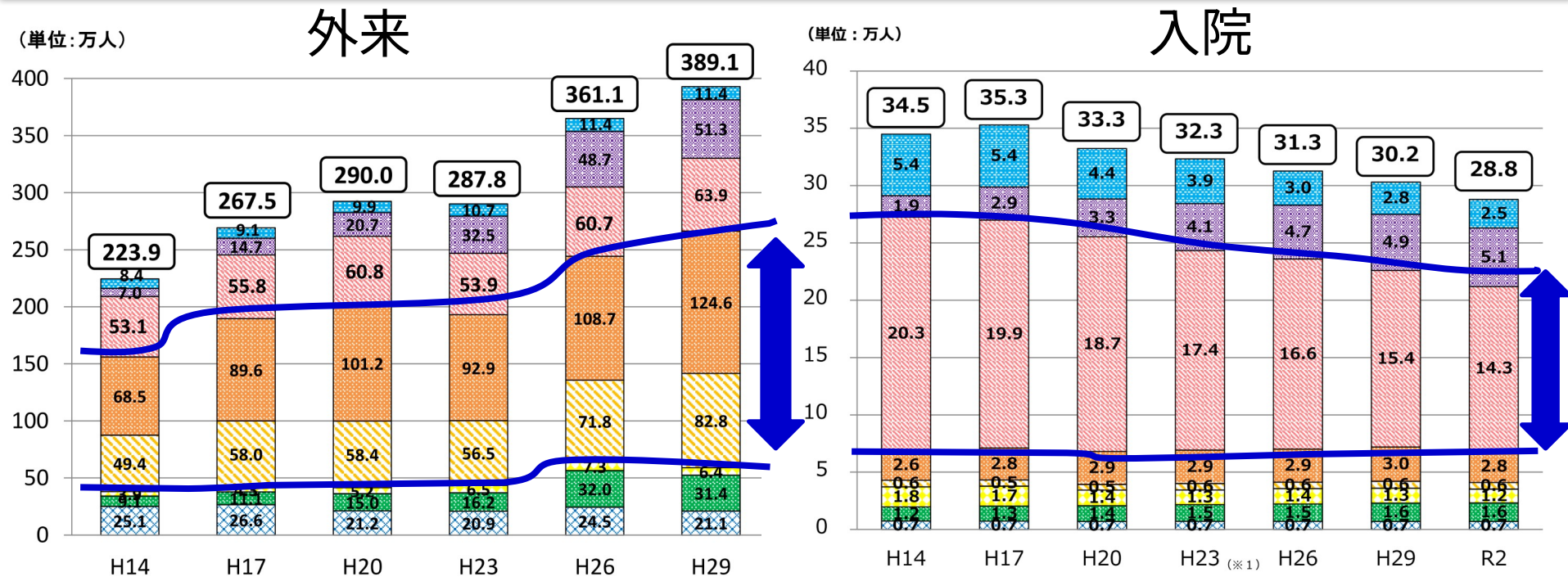
つ

日本の精神医療の特徴

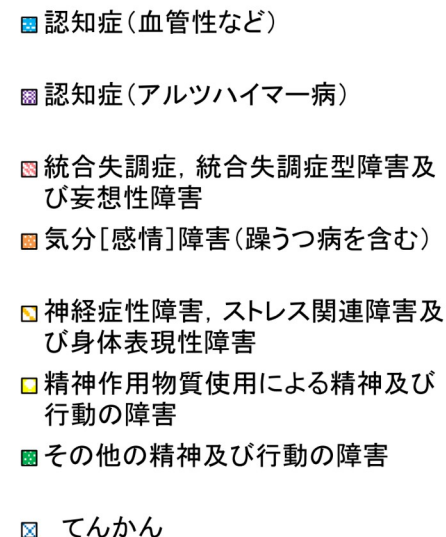


- 外来患者は増加
 - メンタルクリニック増加
- 入院患者は微減.....それでも
 - 精神科病院：病院全体の1割
 - 精神病床：全病床の2割

日本の精神医療の特徴



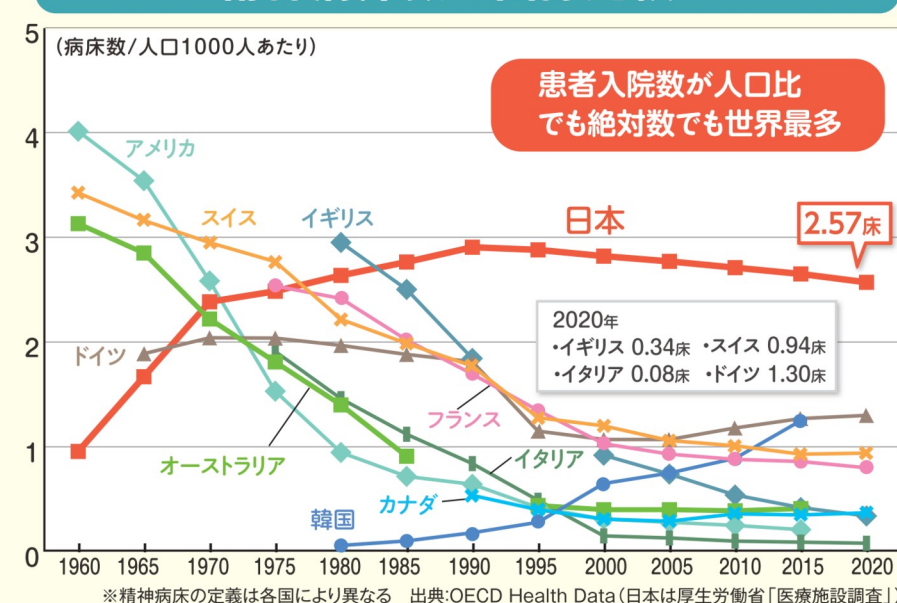
- 外来患者
 - うつ病・不安症が最多：半分
- 入院患者
 - 統合失調症が最多：半分



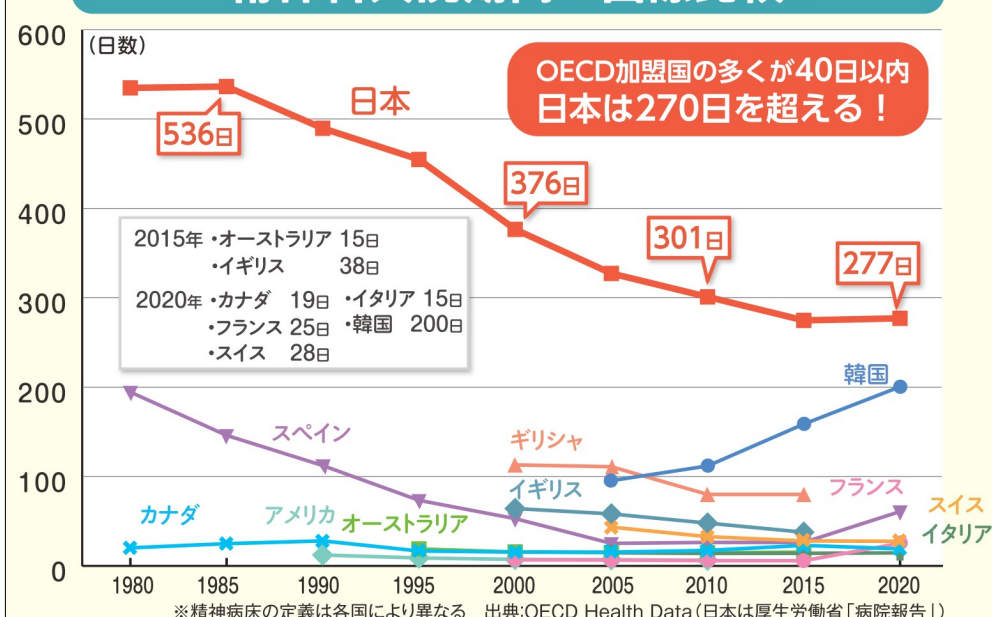
日本の精神医療の特徴

- 世界中の全精神病床の**2割弱**は日本にある！
 - ✓ 精神病床の定義は国により異なるが...
 - 日本の人口は世界の総人口の2%なのに
- 平均在院日数も日本がダントツ
 - 減少傾向にあるが、今でも277日≒9ヶ月もある
 - 一般病床の17倍以上！

精神病床数の国際比較※

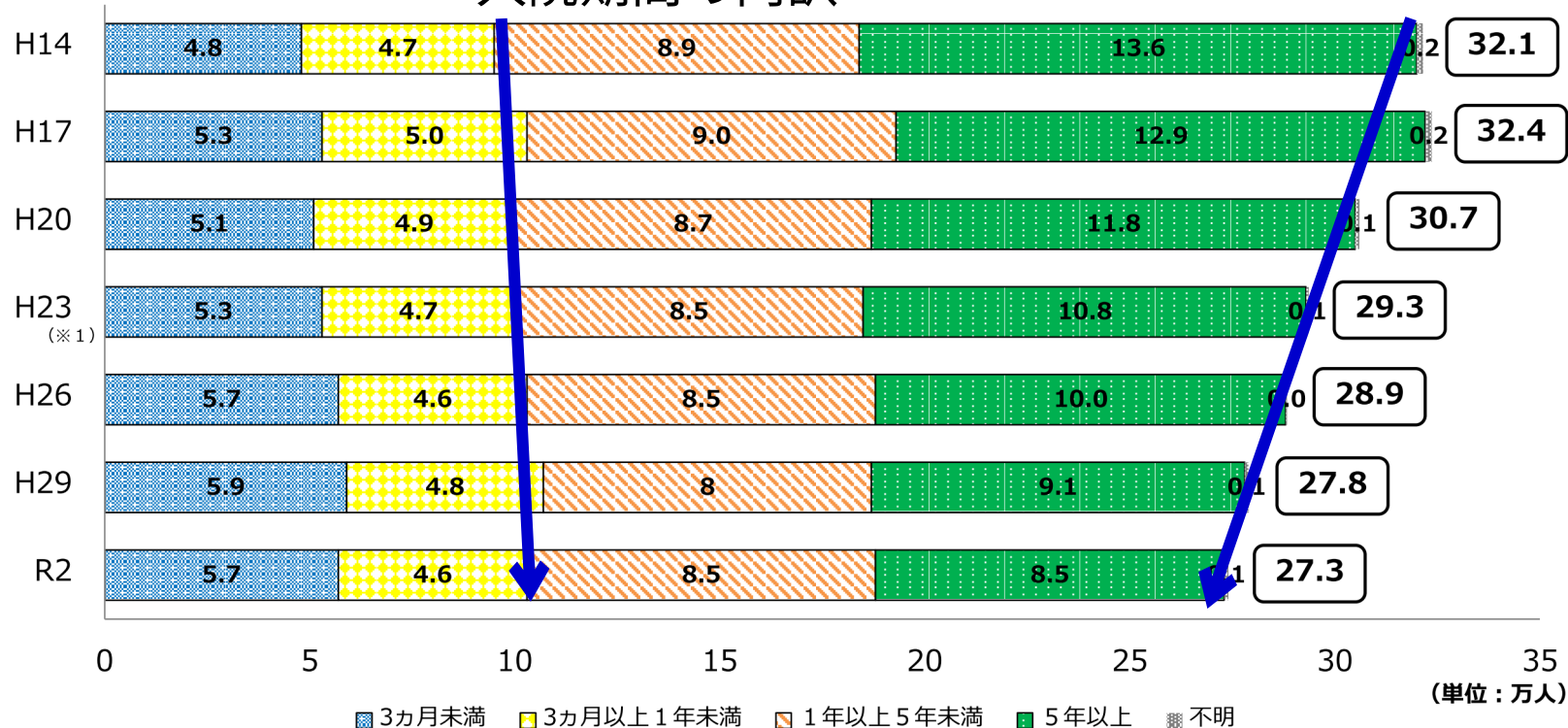


精神科入院期間の国際比較※



日本の精神医療の特徴

入院期間の内訳



- 長期入院は減り，短期入院は増
 - 若い人は早く退院し，高齢者が取り残される
→入院患者は高齢化：高齢者が6割以上

精神科の入院は多くて長

なぜ？

なぜ日本は精神科患者を多く長く入院させるのか？

- 長い入院は良い治療だから？
 - No！入院を求めて受診した統合失調症患者を地域と病院とにランダム割り付け→12ヶ月後，症状もQOLも地域群＞病院群（Acta Psychiatr Scand 1984;69:359-72）
- 精神科医療には医療＋社会防衛が担わされてきたから
 - 「精神障害者は危ない」から施設に閉じ込め社会に出さない
- 精神科医療制度の変遷
 - 1900年（明治33年）精神病者監護法→座敷牢で私宅監置
 - 1919年（大正8年）精神病院法
 - 私宅監置から病院に移そうとしたが資金不足でうまくいかず
 - 1950年（昭和25年）精神衛生法
 - やっと私宅監置をやめ病院で診ることに

座敷牢から精神科病院での収容

精神科患者を多く長く入院させるための制度

- 精神科特例

- 入院患者1人あたりの医療職員数を減らして安上がり
- ✓ 医師は一般病床の1/3, 看護師・准看護師は2/3に

	特定機能	一般	精神
医師1人あたり	8人	16人	48人
看護師1人あたり	2人	3人	4人
薬剤師1人あたり	3人	7人	15人

- ✓ 患者1人1日あたりの平均診療収入: 精神は一般の3割

⇒たくさん入院させないと儲からない

- 平均病床数: 精神 = 231床 vs 一般 = 125床 (医療施設調査2022年)

- 精神科病院の設置主体 = 民間が圧倒的に多い

- 病床数: 民間が91.5%

コストを下げることで大量収容可

能に

精神科患者を多く長く入院させるための制度

- 1950年：精神衛生法→強制入院を制度化
- 1958年：精神科特例→低コスト医療を制度化
- 1960年：医療金融公庫法→精神病院設立へ補助・低利融資
→1950～1970年に民間の精神病院が林立
- 1987年（昭和62年）精神保健法・1995年（平成7年）精神保健福祉法

→患者

の人権擁護がその基本的な目的である。

多く・長く収容する体制が
確立

精神医療の脱施設化

- 欧米
 - 1955年頃に抗精神病薬が導入され脱施設化：病院から地域へ
- 日本
 - 遅まきながら2004年に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を策定
 - ✓ 医療費の削減を目指す：10年で7.2万床削減を目指した
 - ✓ 国際的な批判を受けた
 - 病床削減は未達：2023年でも3.3万床しか削減できず..

なぜ？

⇒精神科病院のほとんどは民間だから削減を強制できない



日本精神科病院協会の山崎学会長

東京新聞2023年7月7日こちら特報部：インタ
ビュー記事

>じゃあ日本も今後は病院ではなく、地域で見守る態勢に本腰を入れるべきだ

「地域で見守る？誰が見てんの？あんた、できんの？きれいごとと言って、結局全部他人事なんだよ」

>確かに社会資源が少ない

「障害年金たった年間70万円で、どうやって地域で生活させんの？できないよ．働けないんだぜ」

>社会構造も変えないと

「変わんねえよ！医者になって60年，社会は何も変わんねえんだよ．みんな精神障害者に偏見もって，しょせんキチガイだって思ってたんだよ，内心は」

>精神科病院に入院し続けることは幸せなのか

「そう思うよ，ぼくは．地域で，アパートで一人暮らししながら，明日のことも分からず生活するのと，病院の4人部屋で皆でご飯食べるのと，どっちがいいかって言ったら，ぼくは病院を選択するよ」

>30年入院してても？

「出してどうすんの？地域でマンツーマンで診れるならいいが財源も人もいない．支えているのはいつもボランティアじゃねえか」

国試過去問：109G6（2015年）

- 最近5年間における精神障害者の医療の実態について正しいのはどれか
 - a. 精神病床の平均在院日数は約90日である
 - b. 精神病床数は人口千人あたり約1床である
 - ☒ c. 精神病床入院患者は65歳以上が約半数を占める
 - d. 精神病床入院患者は統合失調症より認知症が多い
 - e. 精神科外来患者は気分障害より統合失調症が多い

a→入院期間は平均1年弱と覚えていれば✖とわかる

b→細かい数字は覚えなくて良いでしょう

c→入院期間が長くて入院患者が高齢化しているとわかれば○とわかる（今は6割が高齢者）

d→入院では統合失調症が最多で半分と覚えていれば✖とわか

e→外来ではうつ病（気分障害）や不安症が多いと覚えていれば

✖

精神医療の入院

- 判断能力の問題

- 通常，成人は自分のことについて自己決定を行う
- 判断能力に問題がある場合，代理人が判断する
 - ✓子ども：通常は親権者
 - ✓判断能力に問題がある認知症患者や精神障害者：後見人
- 入院についてだけ本人の同意なしに強制的に行う方法がある
精神保健指定医が入院の必要性を判断する

- 精神保健指定医とは

- 本人の意思に関わらず，強制入院や入院継続の必要性，身体拘束や隔離などの入院中の行動制限の必要性を判定できる**国家資格**
- 精神保健福祉法に定められる
- 指定医の取得：精神科の臨床経験3年以上（＋臨床経験5年以上）とケースレポート

精神医療の入院形態：5種類

- **任意入院**：本人の意思による入院。一般の入院と同じ。

それ以外：強制入院。すべて精神保健指定医が判定する。

- **措置入院**

- 自傷他害の恐れがある場合
- 社会防衛の側面が強い→全額公費負担
- 精神保健指定医2名が判定
- 知事に届出→知事の権限で

- **緊急措置入院** = 措置入院の簡易版。基本的に措置入院と同じ。

- 緊急性が高い時，精神保健指定医1名の判定で良いが，入院は72時間まで

- ✓ 自傷他害の恐れを警察や保健所が通報を受けて，精神保健指定医（精神科病院）のところまで連れて行く



強制入院

精神医療の入院形態：5種類

- **医療保護入院**

- 自傷他害の恐れはない？が入院は必要なのに本人が拒否するとき
- 精神保健指定医1名が判定
- **家族の同意**あり（家族がいない時は市町村長の同意）
- 知事に届出→病院管理者（院長）の権限で
- ✓ 家族に連れられて/自分で精神科病院を受診するのが基本

家族と連絡が取れない場合はどうするの？

- **応急入院**≡緊急医療保護入院：家族の同意のない医療保護入院

- 精神保健指定医1名が判定
- 入院は72時間まで
- 指定を受けた一部の精神科病院でのみ可能
- 知事に届出→病院管理者（院長）の権限で

5つの入院形態のまとめ

- **入院が必要なとき：入院に同意するか？**

- 同意する→任意入院
- 同意しない

- **自傷他害の恐れがあるか？**

- ある→措置入院（緊急性が高い場合は緊急措置入院）
- ない

- **家族の同意が得られるか？**

- 得られる→医療保護入院
- 得られない→応急入院

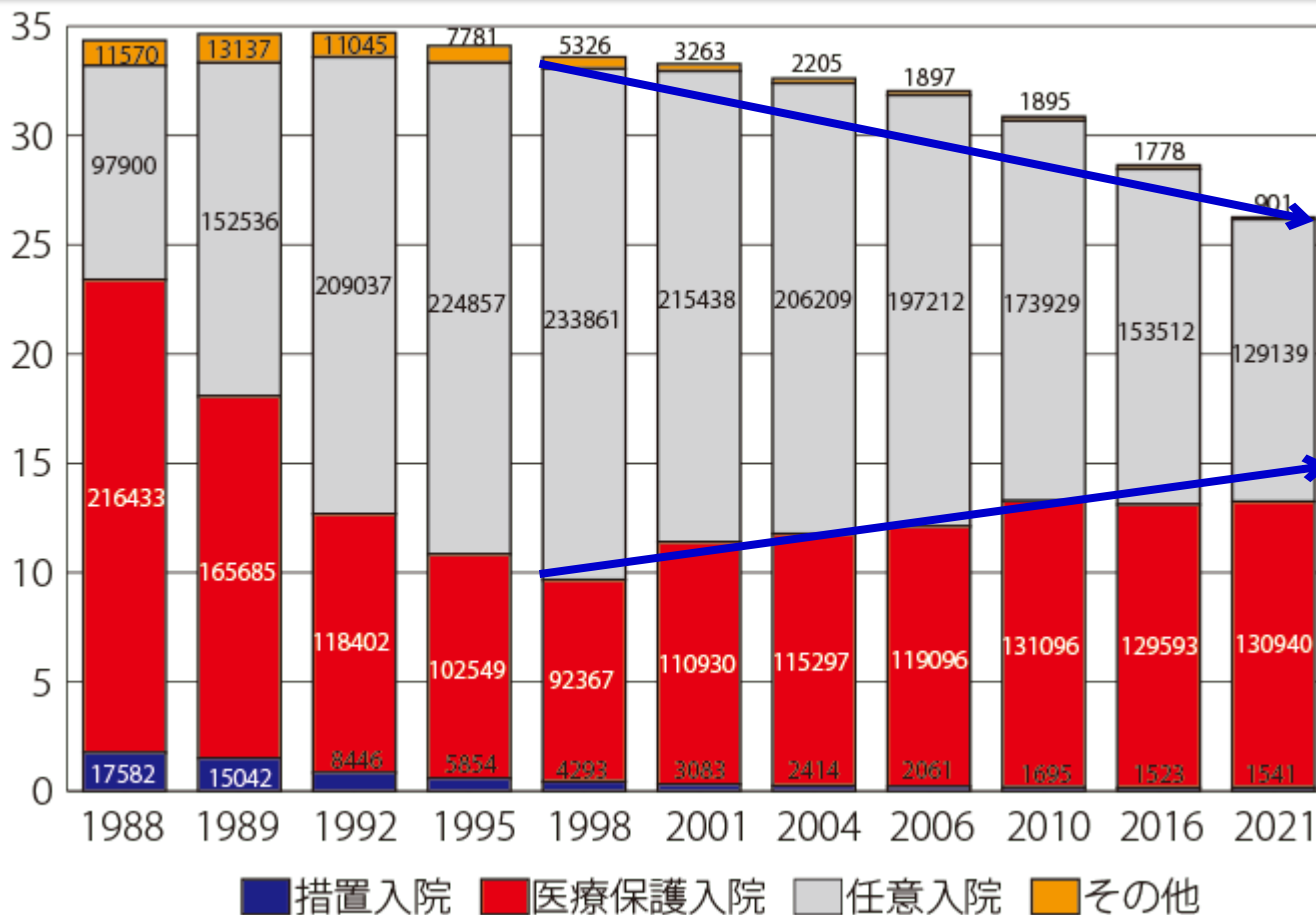
✓強制入院やその退院請求の届出先はすべて知事

✓措置入院だけ知事の権限での入院（それ以外は院長）



強制入院

5つの入院形態の割合



- 任意入院と医療保護入院が半々
 - 任意入院↓ vs. 医療保護↑
- 措置入院（緊急措置入院）は1%未満，応急入院は≒0%
 - 措置入院は減少傾向

強制入院の国際比較

	調査年	非自発入院者 割合 (%)	人口 100 万人対	精神障害による 非自発入院法的基準
日 本	2013	46.0%	1,087 人	危険性 or 治療必要性
オーストラリア	1999	18.0%	175 人	危険性
ベルギー	1998	5.8%	47 人	危険性
デンマーク	2000	4.6%	34 人	危険性 or 治療必要性
フィンランド	2000	21.6%	218 人	危険性 or 治療必要性
フランス	1999	12.5%	11 人	危険性
ドイツ	2000	17.7%	175 人	危険性
ギリシャ	NA	NA	NA	危険性 or 治療必要性
アイルランド	1999	10.9%	74 人	危険性 or 治療必要性
イタリア	NA	12.1%	NA	治療の必要性
ルクセンブルグ	2000	NA	93 人	危険性
オランダ	1999	13.2%	44 人	危険性
ポルトガル	2000	3.2%	6 人	危険性 or 治療必要性
スペイン	NA	NA	NA	治療の必要性
スウェーデン	1998	30.0%	114 人	治療の必要性
イギリス	1999	13.5%	48 人	危険性 or 治療必要性

(注) ・ NA Not available

(出所) Saize Hj, et al (2004 : 164-166) 及び平成 25 年度精神保健福祉資料を

日本はダントツに多い

国試過去問：103E46（2009年）

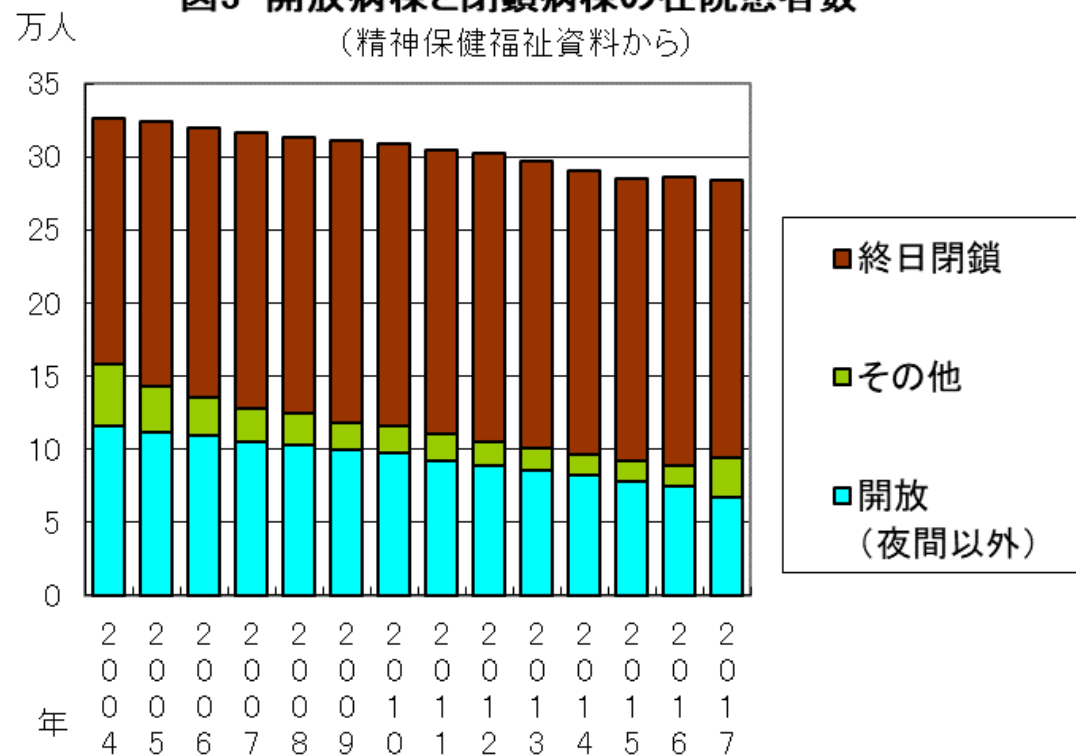
- 27歳の男性。言動の変化を心配した妻に連れられて来院した。半月前から「盗聴されている」と言って部屋にこもり、仕事に行かず、食事もありとらない。精神保健指定医が診察し、入院が必要であると診断したが、本人は入院を拒んでいる。妻は入院の必要性をよく理解している。対応として最も適切なのはどれか？

- a. 外来治療 ←精神保健指定医が入院が必要だと診断より
- b. 任意入院 ~~×~~ ←本人は入院を拒否より
- ☒ c. 医療保護入院 ~~×~~ ←妻（家族）は入院に同意より
- d. 措置入院 ←^り自傷^り他害の恐れがないから
- e. 応急入院 ~~×~~ ←家族がいる（連絡がつく）から ~~×~~

精神医療の行動制限：閉鎖病棟

図3 開放病棟と閉鎖病棟の在院患者数

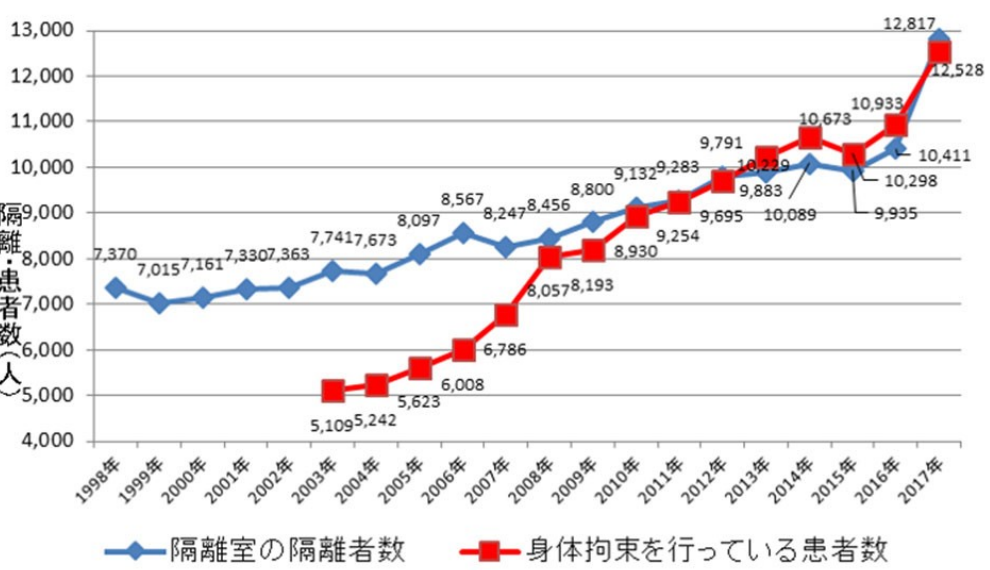
(精神保健福祉資料から)



- 閉鎖病棟：自由に出入りできない病棟：74% (2022年)
- 開放病棟：昼間は自由に出入りできる病棟：21% (2022年)
 - 任意入院の患者の多くが閉鎖病棟に入ること

精神医療の行動制限：隔離・身体拘束

ある1日の隔離・身体拘束者



隔離・身体拘束者数 (/10万人・年)

	隔離	身体拘束
日本	190	120
オーストラリア	48	6
ニュージーランド	54	0.7
アイルランド	38	3.1
イングランド	17	1.9
アメリカ	7.5	18
ドイツ	80	81
オランダ	96	22

BJPsych Open 2024 ;10:e26

- ・ 隔離：鍵のかかる個室に入る
- ・ 身体拘束：ベルトやベルト付き衣服で動けなくする
- ・ 日本は他国よりダントツに多い

保護室

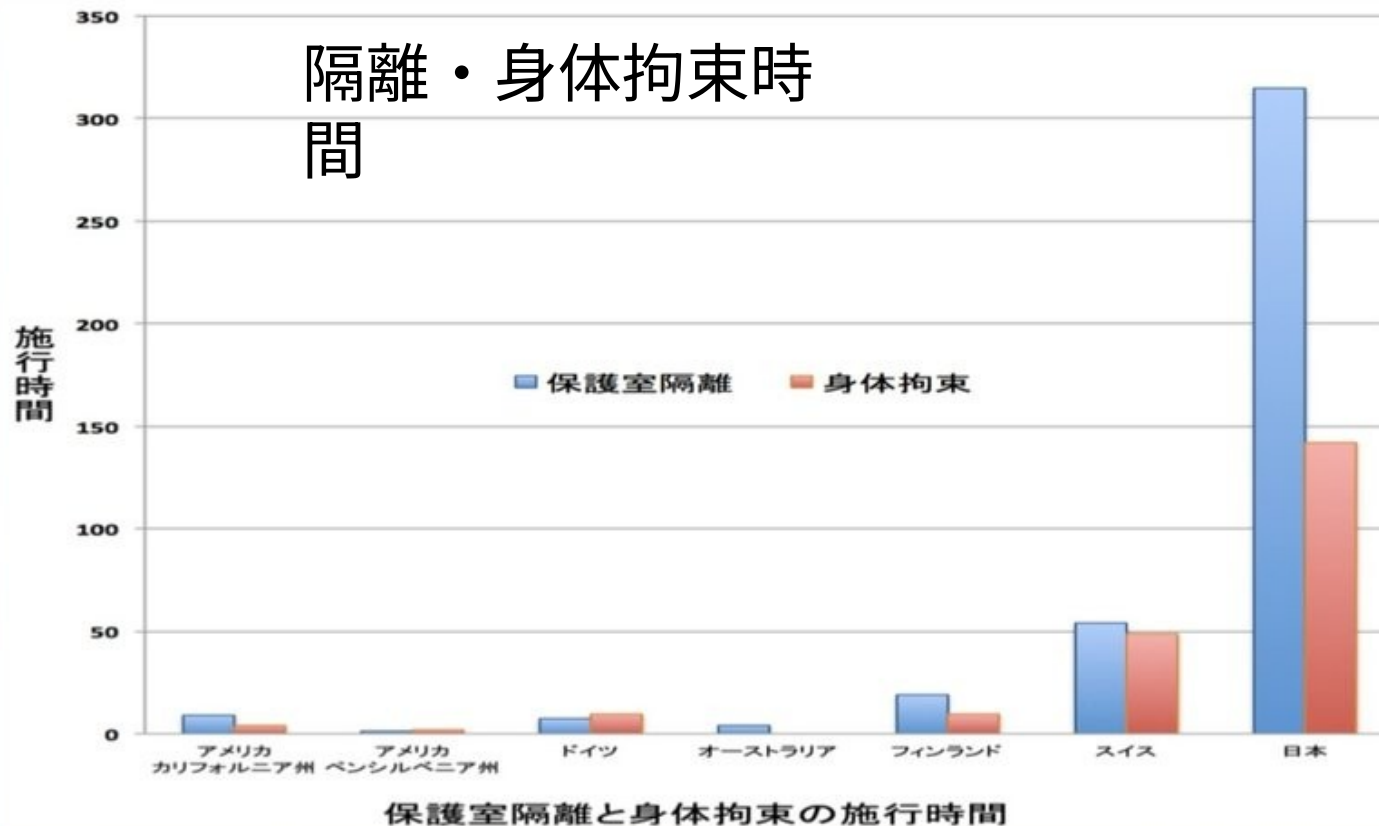


身体拘束



精神医療の行動制限：隔離・身体拘束

隔離・身体拘束時間



諸外国のデータ: 長谷川利夫(2013). 精神科医療の隔離・身体拘束.(日本評論社).

本邦のデータ: 野田寿恵・杉山直也・佐藤真希子・伊藤弘人・Eila Sailas・Hanna Putkonen・Raija Kontio・Grigori Joffe. (2014). 隔離・身体拘束施行時間に影響する患者特性—日本の精神科急性期医療. 精神神経学雑誌, 116, 805-812.

- 国際的に見て圧倒的に長い
 - 1ヶ月を超える人も相当いる

精神医療の行動制限：通信・面会制限

- 手紙の制限は一切できない
- **電話と面会の制限は治療に正当性のある場合は可能**
 - 弁護士や人権を擁護する行政機関の職員との電話や面会は制限できない
 - ✓ 退院請求
 - ✓ 行動制限の不当性について審査請求
 - でも、行動制限中は通信・面会はできない....

手紙，弁護士との通信・面会，退院請求は制限不可

強制入院や行動制限の正しさを誰が審査するの？

精神医療審査会

- 強制入院中の患者さんや保護者などから退院や処遇改善の請求があった時に、入院の必要性や処遇が適切かどうかについて審査を行う第三者機関.
- 精神保健福祉法が定める
- チェックが効いているか？ →NO
 - 退院請求のうち、退院が認められたのは0.8%（2014年）
な
 - 過半数が医療関係者、事務局が行政機関（精神福祉保健センター）に置かれ独立性が弱い
 - 1回の審査で膨大な数を判定

強制的な処遇が多く・長く・きつくなる理由

- 少ない医療スタッフで多くの患者のケアをせざる得ない
⇒行動制限を最小化するためには、手厚い人員配置が必要
- 法的な規制の緩さ
 - 強制的な入院，隔離・身体拘束，面会・通話の禁止などすべて精神保健指定が決定できる
 - 第三者機関とされる精神医療審査会は十分機能していない
⇒精神保健指定医が退院を許可しなければいつまでも入院が続く

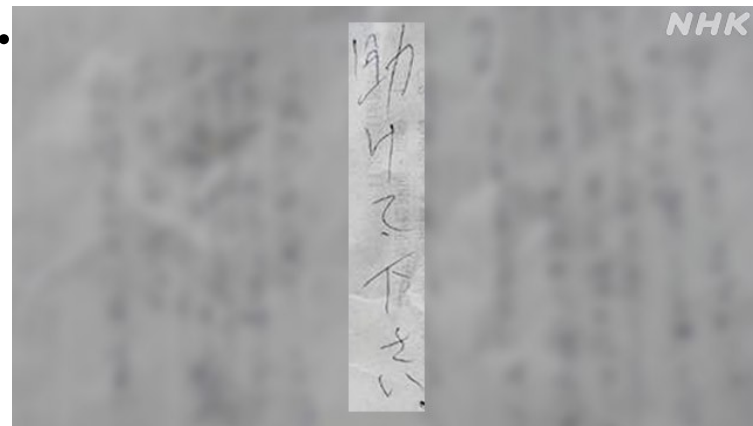
他の先進国では

- 強制的な処遇の決定には司法機関が関与するのが一般的
⇔日本は医師（精神保健指定医）と行政機関のみ
- 隔離収容をしない：入院は最小限で地域医療に金をかける
⇔日本は入院が多過ぎ地域医療に金をかけない

日本の精神医療の闇：NHK ETVで特集

- 伊藤時男さんの例
 - 39年間、福島県の精神科病院に入院
 - 2011年の原発事故で別の精神科病院に移り、入院の必要なしとされ退院
 - ✓ 原発近くの5つの精神科病院から52人が福島県立矢吹病院に移る（半数は入院25年以上）→9割は入院の必要なし
- 滝山病院事件
 - 違法な行動制限，暴力が蔓延
 - ✓ 手紙を書くためのペンを使えるのは1日2時間のみ
 - ✓ 電話や手紙など通信の内容は検閲あり
 - まともな医療なし：死に至るケース多数
 - 死亡退院率78%
 - ⇒2021年の内部告発で発覚し，看護師5人逮捕

- 院長は、埼玉県にあった朝倉病院の元院長．2001年に患者数十人の不審死が発覚し，診療報酬の不正請求により保険医の登録取り消し．病院は廃院に
- 「ここね、人が人を殺すところなんです．僕を助けてください．お願いします．僕は死にたくないんです」悲痛な声で弁護士に救助を訴えていた幸田さん
 - 弁護士との面会から1か月も経たないうちに病院内で謎の死を遂げた．病院側の診断は「急性心不全」．原因は不詳とされ，享年46歳だった．



- 2023年2月25日NHK ETVで報道
 - 日本精神科病院協会が現地調査へ
 - 厚生労働省は、都や八王子市とともに異例の立ち入り指導
 - 第三者委員会が実態を調査中

国試過去問：111G48（2017年）

- 22歳の男性．行動の異常を心配した家族に連れられて来院した．自室に閉じこもり，つじつまの合わない言動がみられるという．幻聴，被害妄想および精神運動性障害を認めた．器質的な要因が認められず，統合失調症で入院が必要と判断され，父親の同意によって医療保護入院となった．しかし患者は「自分は病気ではない．入院の必要はない」と主張して，退院請求を出すことを希望した．患者への説明として正しいのはどれか．
 - a. 「医療保護入院なので退院請求はできません」
 - b. 「精神保健指定医は退院請求を却下できます」
 - c. 「退院請求は精神保健福祉センター長に対して行います」
 - ☒ d. 「退院請求の審査は精神保健審査会で行われます」
 - e. 「審査結果はあなたではなく，病院に報告されます」

国試過去問：115F55（2021年）

- 22歳の男性。家庭内で自室に閉じこもり「おれの悪口を言うな」, 「外を通る人が窓からのぞいている」などの実際には認められないことを口走ることが多くなったため, 両親とともに来院した。診察した精神保健指定医は, 治療が必要であるが本人に治療意欲がないことを考え, 医療保護入院とした。禁止できるのはどれか。2つ選べ。

- ☒ a. 弁護士との面会
- ☒ b. 両親あての手紙
- c. 友人あての電話
- d. 家族の希望による自宅外泊
- ☒ e. 精神医療審査会への退院請求

日本の強制入院の問題点

- 他の先進国では強制入院の決定には、精神科医と司法機関の双方が関与するのが一般的
 - 緊急時は精神科医が判断→長期化する際は、裁判所や準司法機関が判断する。患者には代理人弁護士がつく。
- 日本では、司法機関の関与がなく、精神科医と行政機関のみが強制入院に関わる
 - プレーヤー＝審判となるのを避ける理由付けとして、**精神保健指定医**という役割を作ったが...
 - 透明性がなく、不当な入院が生じ、人権保護が不十分
- 日本は2014年に障害者権利条約を批准
 - 国連の審査で、①強制的な入院治療を廃止、②精神科病院に対する独立した監視機構の設立、③無期限の入院をやめること等を勧告された（2022年）